

Diagnóstico e Prognóstico

Cesar Alfredo Pusch Kubiak e Celmo Celeno Porto

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico (do grego *dia* – através de + *gnosis* – conhecimento, ou seja, discernir pelo conhecimento) é a base da atuação de médicos e outros profissionais de saúde, sendo um propósito imperativo a ser alcançado. É definido, segundo Mason, “como uma série de procedimentos de ordem intelectual (cognitiva) e operacional (atitudes e habilidades) através dos quais se obtém uma resposta a um determinado problema clínico”. Dada sua importância, quando não é esclarecido, não são estabelecidas adequadamente as intervenções terapêuticas, não é possível acompanhar o quadro evolutivo, nem se estabelecer o prognóstico. Vale dizer: sem diagnóstico não haverá terapêutica correta. Não se pode monitorar a evolução das doenças, nem atingir a preservação ou a restauração das funções, comprometendo o ato médico em seu todo.

Fatores que contribuem para o diagnóstico

- **Conhecimento médico.** Indispensável para que o profissional esteja familiarizado com os sintomas comuns na atenção primária (febre, síndromes dolorosas, dor torácica, cansaço, astenia, vertigens, tonturas, diarreias, infecções de vias respiratórias superiores (virais e bacterianas), tosse, insônia dentre outros); bem como as entidades nosológicas prevalentes em nosso país: doenças cardiovasculares (hipertensão arterial, dislipidemias, aterotrombose, insuficiência coronariana aguda e crônica, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico), diabetes melito, osteoartrose, depressão, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções do sistema urinário, dispepsias, doenças endêmicas (dengue, chikungunya, zika, tuberculose, malária, doença de Chagas, AIDS, hanseníase, enteroparasitoses e ectoparasitoses).
- **Obtenção competente e valorizável de dados.** Por meio da história clínica e do exame físico (incluindo dados objetivos e subjetivos como linguagem corporal, estado de humor, sinais de sofrimento, estado nutricional, estado geral).
- **Registros organizados.** Documentação científica sistematizada (prontuário médico).
- **Tempo necessário para obtenção de um excelente prontuário médico.** Dedicção de, em média, 30 a 50 minutos a cada paciente em consulta inicial.
- **Capacidade de integrar dados.** Em conjuntos significativos, seguindo a lógica do raciocínio clínico.
- **Lista dos achados em ordem de importância e significância (lista de problemas) e a transdução linguística semiótica.** Permite a elaboração de roteiro com o arcabouço diagnóstico, singular a cada profissional e mutante a cada dado agregado ou rejeitado.
- **Uso racional e criterioso de exames complementares.**
- **Busca do diagnóstico conclusivo.** Por meio da seleção da nosologia que explique da melhor maneira todos os achados.
- **Revisão do diagnóstico.** Quando o curso clínico não for o esperado valorizando novos dados positivos.

A elaboração diagnóstica depende de uma base de conhecimentos amplos – fundamentais –, além de conteúdos de anatomia, fisiologia, patologia, psicologia, semiologia, e conhecimento de entidades nosológicas prevalentes.

Um médico resolutivo deve conhecer e saber identificar cerca de 300 entidades nosológicas, acessar fontes de informação seguras, elaborar registro e listar problemas, desenvolver habilidades em comunicação, ter desenvoltura social, ser continente, empático, ser capaz de exercitar uma contratransferência construtiva, ser adequado em sua postura e atitudes como médico, um conjunto de qualidades que lhe permitam se apropriar da almejada **perícia clínica** (ver Capítulo 4, *Ensino/Aprendizagem da Relação Médico-Paciente*).

O processo do diagnóstico é árduo. Na relação médicopaciente, outrora restrita a duas pessoas, em que o médico tinha o arbítrio de decidir pelo necessário e o que fazer de melhor para o seu paciente; hoje vicejam “atravessadores” midiáticos (revistas, jornais, televisão, internet) ou institucionais (planos de saúde, cooperativas médicas, seguro-saúde, Sistema Único de Saúde, indústria farmacêutica e fornecedores de toda ordem) que estabelecem regras de comportamento e limites na atuação dos médicos, com restrições de tempo para a consulta, na solicitação de exames complementares e influenciando na escolha das condutas terapêuticas. A prática de uma segunda ou terceira opinião (consulta) tem sido comum, principalmente em processos diagnósticos de maior complexidade ou importância clínica, situação esta que, na dependência da linguagem empregada na verbalização dos fatos, gera conflitos, distorções, mal-entendidos e não raros processos judiciais ou administrativos sob a justificativa de má prática e erros de diagnóstico e condutas.

O advento de *sites* de busca, como o Google, facilita o acesso a informações para pacientes e familiares, em geral, nas seguintes situações:

- Quando se sente doente
- Quando há um familiar enfermo
- Após diagnóstico firmado
- Antes de iniciar algum tratamento ou se submeter a procedimentos
- Quando um novo tratamento é anunciado.

O leigo, não conhecendo a matéria médica, não terá critérios para selecionar e avaliar o material consultado, fato que por vezes atrapalha o processo diagnóstico ou terapêutico, pois sugerem exames e/ou condutas, a partir de diagnósticos fantasiosos por ele elaborados ou por falácias científicas que lê e vê (informação sem formação não gera conhecimentos).

Outro aspecto a ser considerado na elaboração diagnóstica diz respeito à situação em que atendemos o paciente: paciente horizontal (hospitalizado) ou paciente vertical (ambulatorial), conforme se expressou Kloetzel. Neste último, quase sempre, estaremos diante de doenças comuns, benignas, de curta duração e por vezes autolimitadas, de reconhecimento diagnóstico eventualmente dificultado por mascaramento de sinais e sintomas, podendo induzir o médico a utilizar “rótulos diagnósticos”, como virose, gastroenterite, síndrome gripal, nevralgia, labirintite.

Neste cenário de atendimento podemos exercitar a **demora permitida, quando o diagnóstico for mais complexo (p. ex., doenças raras) ou o paciente for portador de várias morbidades**, ou seja, tratando-se de um paciente portador de doença crônica (“de progresso lento, duração longa e desprovida de resolução espontânea”), sem risco de vida mediato. Nestes casos é correto fazer o atendimento de forma escalonada em várias consultas, elegendo prioridades a serem abordadas (Kloetzel, 2004).

Outro aspecto a ser discutido são os **achados casuais**. Podemos exemplificar com o caso de um paciente que vai à consulta por conta de diarreia secretória, e, durante o exame físico, identifica-se um quadro de dermatite seborreica – achado casual, que não deve desfocar a atenção do motivo real da consulta.

Em princípio, devemos ter como meta o diagnóstico de **uma única doença** que explique todas as queixas do paciente e os achados do exame físico; contudo, em pessoas idosas esta regra não pode ser aplicada, pois é comum apresentarem três ou mais doenças. Neste caso, é necessário hierarquizar os diagnósticos, ou seja, o que provoca mais sofrimento ou põe em risco a vida do paciente (ver Capítulo 181, *Semiologia do Idoso*).

Regras práticas

Faça sempre a sua (pessoal) observação clínica (anamnese e exame físico). Evite usar a observação clínica de outrem, para ganhar tempo ou agilizar o trabalho.

Quanto menos precisas forem as definições da síndrome clínica, da entidade nosológica e da hierarquização do diagnóstico diferencial, mais difícil será a escolha e a seleção de exames complementares de maior especificidade e sensibilidade para confirmar o diagnóstico e eliminar as hipóteses diagnósticas não pertinentes.

Quanto mais inadequada a anamnese, maior a dependência aos dados dos exames físico e complementares.

Não se esqueça: quando chegamos ao final da história clínica, **sem elementos ou noção** de qual síndrome ou nosologia é a mais provável, **difícilmente** iremos mais longe com os exames físico e complementares.

Sintoma, sinal, síndrome, entidade nosológica

Sintoma é uma sensação subjetiva anormal percebida pelo paciente e não observada pelo examinador (inspeção, palpação, percussão e ausculta). Exemplos: dor, náuseas, dormência, insônia, má digestão.

Sinal é um dado objetivo notado pelo paciente e observado pelo examinador através do método clínico ou de exames complementares. Exemplos: tosse, edema, cianose, presença de sangue na urina (hematúria) ou condensação pulmonar na radiografia de tórax.

Síndrome (do grego *syndromos* – andar junto) é um conjunto de sintomas e/ou sinais que ocorrem associadamente e que podem ter diferentes causas. Exemplos: síndrome febril (hipertermia, taquicardia, taquisfigmia, sudorese, tremores, mialgias, artralgias), podendo se relacionar com infecções bacterianas, virais, fúngicas, neoplasias malignas. Outros exemplos: síndrome diarreica, síndrome dolorosa, síndrome consumptiva.

Entidade nosológica é, em geral, uma doença bem definida com alteração de função de órgãos ou sistemas, ou mesmo perda destas funções com suas consequências e repercussões.

Há doenças em que não podemos intervir, ou intervir muito pouco, como as genéticas, assim como há doenças de causas bem definidas em que o tratamento é curativo, como as infecções bacterianas, virais ou fúngicas. Em algumas, teremos condições de intervir na disfunção de modo definido (reduzir ou eliminar o edema da insuficiência cardíaca), sem a restauração plena da função, e em outras precisaremos da participação (adesão) do paciente como, por exemplo, modificações de hábitos de vida (cessação do tabagismo na doença pulmonar obstrutiva crônica, restrição de hidratos de carbono na dieta dos diabéticos, realização de atividades físicas nas doenças cardiovasculares, redução de peso na obesidade).

Entidade nosológica é uma condição clínica cuja história natural está reconhecida em seu todo ou em parte, cujas características lhe dão personalidade e individualidade, permitindo que seja catalogada, identificada e reconhecida.

Modernamente temos tido oportunidade de analisar e refletir sobre as doenças iatropatogênicas ou iatrogênicas, entendidas como **lesão, dano ou prejuízo** ocasionado pelo médico e outros profissionais da área de saúde, pela medicina e por estabelecimentos de saúde, podendo ser de ordem física, mental, social ou espiritual, quer de forma direta ou indireta. Assim teremos a iatrogenia dos atos e das palavras, dos procedimentos e medicamentos, algumas destas situações alvo de escrutínio jurídico-legal e cabíveis de punição ética, penal e criminal.

Raciocínio diagnóstico

Entende-se como diagnóstico clínico a identificação de uma entidade nosológica (doença), contemplando aspectos técnicos e operacionais necessários ao seu reconhecimento, posterior registro e catalogação junto ao serviço de documentação científica e ao Código Internacional de Doenças. Não é um processo estático, sendo permeado de componentes variados da pessoa quando enferma (como os aspectos emocionais, sociais e situacionais), razão pela qual alguns autores propõem a substituição do conceito de diagnóstico como objetivo da consulta por “processo de resolver problemas médicos” (Titton, 1988).

O raciocínio clínico é baseado mais em probabilidades do que em certezas. E a probabilidade é o conceito segundo o qual o valor preditivo de um teste ou achado clínico depende não apenas de sua sensibilidade e especificidade, mas também da probabilidade prévia (ou seja, da prevalência da doença na população estudada).

Pode ser conceituado também como **“o conjunto dos processos de pensamento pelos quais os profissionais de saúde selecionam, interpretam, analisam e combinam informações com o objetivo de tomar decisões sobre**

um paciente em uma determinada situação clínica”(Association for Medical Education in Europe – AMEE).

O raciocínio clínico usa, na verdade, os princípios e as habilidades do **pensamento crítico** (*critical thinking*), que é o processo intelectualmente disciplinado para, ativa e habilmente, conceituar, aplicar, analisar, sintetizar e/ou avaliar uma **informação**, obtida ou gerada por observação, experiência, reflexão ou comunicação, como um guia para o **aprendizado** ou para a **ação**. O pensamento crítico é baseado em **valores intelectuais** que transcendem os conteúdos, tais como: clareza, acurácia, precisão, consistência, relevância, sólida evidência, profundidade, extensão e fidelidade (Gordan, 2017).

A resolução de um problema médico tem um ponto inicial claro e uma meta bem definida. A tarefa de resolver um problema de saúde (diagnóstico) consiste em achar o caminho entre estes dois pontos. O método científico de testar hipóteses procurando qual das alternativas deixa a meta final mais próxima é o que deve ser aplicado em regra.

Pode ser centrado em sintomas quando o conjunto de sintomas é comparado com o grupo de doenças que os apresentam, formando um grupo reduzido de possibilidades. É o reconhecimento de “padrões”. A identificação se aclara quando apenas uma doença se encaixa e permanece, justificando o quadro clínico apresentado.

O método também pode ser centrado na doença. Formulando-se a interrogação: tem o paciente a doença X? Conhecendo-se os sintomas reveladores, o arquétipo das entidades nosológicas e respectiva história natural, podemos checar no paciente quais dados serão úteis para o diagnóstico.

Grande parte deste processo é puramente mental, com elementos analógicos (intuição) atuando de forma intensa com os elementos lógicos (racionais) decorrentes da formação médica (cultura) e do aprendizado prático (habilidades e competências).

Caminhos para a definição diagnóstica

Reconhecimento de um padrão em que a inferência é intuitiva, o diagnóstico “fácil” do “já visto” – reconhecimento por *gestalt* –, o famoso “olho clínico”, muitas vezes baseado na narrativa. Exemplo: o diagnóstico das doenças exantemáticas comuns: sarampo ou catapora, é simples aos olhos de um pediatra, fruto de seu conhecimento, experiência, vivência e frequência com que se depara com estas enfermidades.

Fluxograma, baseado em diretrizes, consensos, protocolos e guias – inferência dedutiva, na qual identificamos sinais e sintomas em uma árvore diagnóstica e percorremos caminhos e etapas preestabelecidas, que convergem para um diagnóstico final. De grande valia para os serviços de pronto atendimento e úteis para médicos jovens que passam a ter uma parametrização confiável nas suas decisões.

Método da exaustão, em que esmiuçamos detalhes da anamnese e o exame físico meticuloso, na presunção de que a narrativa forneça pistas e elementos para identificarmos a doença em questão, corroborado pelo exame físico detalhado, sistematizado. Lembrando que neste processo o “entorno” do problema principal ou o “contexto” de que participa o paciente é de grande valia [aspectos sociais (ambiente familiar, ambiente de trabalho), familiares (relações, conflitos), escala de valores, crenças].

Método hipotético-dedutivo, valorizando-se queixas, sinais, sintomas e achados, a serem correlacionados com os conhecimentos de epidemiologia clínica que vão gerar hipóteses.

Na sequência, o raciocínio clínico permitirá a possibilidade do diagnóstico final, usando para isto comparação com modelos, peso de evidências e descarte de hipóteses não validadas.

Outro caminho é o raciocínio fisiopatológico, baseado na história e evolução temporal do quadro clínico – valorizando as queixas, sinais, sintomas e achados semiológico e as suas modificações no decorrer do processo nosológico.

O médico experiente tende a limitar o número de hipóteses a serem testadas. Três ajudas heurísticas contribuem para isto: (1) só evoque uma hipótese se houver dados clínicos suficientes para isto; (2) quando o conjunto de dados gerar várias hipóteses, aplique as informações epidemiológicas sobre a frequência e a prevalência da doença em suspeição, analisando as mais frequentes e prevalentes antes de pensar nas raridades e exceções; (3) use testes discriminadores (exames complementares) entre as hipóteses que permaneceram, escolhendo os de maior acurácia e especificidade.

Passada a fase silenciosa do diagnóstico em que a mente do médico trabalha ativamente integrando dados, passa-se à fase operacional do diagnóstico firmado que consiste na explicação dos fatos ao paciente, da tomada de decisões compartilhadas, quanto à investigação complementar, à terapêutica (não farmacológica, farmacológica, cirúrgica) e ao prognóstico.

Tipos de diagnóstico

Desde os primórdios da medicina, procurou-se conhecer a natureza e as causas das enfermidades.

Seguindo-se a fase mística ou religiosa da medicina, surgiu com a civilização grega a medicina empírica, na qual as doenças passaram a ser consideradas como fenômenos naturais. O mais alto representante dessa fase foi Hipócrates (460-355 a.C.), com justiça considerado o pai da medicina, por ter valorizado a observação clínica e ter feito da anamnese e do exame físico os fundamentos da prática médica.

Desde então, pela observação cuidadosa dos pacientes, muitas doenças puderam se reconhecidas por seus sintomas e sinais, e pela sua evolução, antes que se conhecessem suas causas. Surgiu, dessa maneira, a possibilidade do **diagnóstico**, ou seja, de reconhecer uma dada enfermidade por suas manifestações clínicas, bem como de prever a sua evolução e o **prognóstico**.

O reconhecimento de uma doença com base na anamnese e no exame físico constitui o **diagnóstico clínico**, nem sempre factível sem o auxílio de outros métodos semióticos.

Muitas doenças cursam com um conjunto de sintomas e sinais semelhantes, configurando uma **síndrome**. O reconhecimento de uma síndrome constitui o **diagnóstico sindrômico**, o qual é muito útil na prática médica, pois, mesmo não identificando a doença, reduz o número de possibilidades e orienta as investigações que devem ser realizadas.

Síndrome

Síndrome é um grupo de sintomas e sinais indicativos de distúrbio funcional e relacionados entre si por uma particularidade anatômica, fisiopatológica ou bioquímica.

Os distúrbios de cada sistema orgânico nos seres humanos são redutíveis a um número relativamente pequeno de síndromes.

O raciocínio diagnóstico é muito facilitado quando um determinado problema clínico se enquadra em uma síndrome bem definida, porque apenas algumas poucas doenças terão que ser consideradas no diagnóstico diferencial. Ao contrário, a pesquisa da causa de uma doença que não se enquadra em uma síndrome é muito mais difícil, pois pode haver necessidade de considerar um número muito grande de doenças.

Determinadas doenças produzem modificações anatômicas que podem ser identificadas no exame clínico, permitindo o **diagnóstico anatômico**. Paralelamente ao diagnóstico anatômico, coloca-se o **diagnóstico funcional** ou **fisiopatológico**, que traduz o distúrbio da função do órgão atingido pela enfermidade e se expressa principalmente por sintomas.

À medicina empírica sucedeu a era da medicina científica, cujo início pode situar-se no século XIX. Os grandes progressos alcançados desde então vieram permitir outras formas de diagnóstico.

A descoberta dos microrganismos por Pasteur, o melhor conhecimento dos processos bioquímicos e metabólicos, a descoberta dos hormônios e das vitaminas, o desenvolvimento da imunologia, entre outras conquistas, ensejaram a identificação das causas de muitas doenças, o que tornou possível o **diagnóstico etiológico**.

Ao mesmo tempo, o uso do microscópio no estudo dos tecidos permitiu o **diagnóstico histopatológico** das lesões. O exame a um só tempo macro- e microscópico de peças cirúrgicas ou *post mortem*, englobando os diagnósticos anatômicos e histopatológicos, constitui o **diagnóstico anatomopatológico**.

A utilização rotineira da radiografia e de outros exames de imagem como auxiliar quase obrigatório do diagnóstico fez nascer o **diagnóstico radiológico**, o **tomográfico**, o **ultrassonográfico** e outros. Cada método novo de exame que vai sendo introduzido na prática médica conduz a novas formas de diagnóstico, e fala-se hoje, correntemente, em diagnóstico laboratorial, sorológico, eletrocardiográfico, endoscópico, e assim por diante.

Quando era ainda empírico e sintomático o tratamento das doenças, a importância do diagnóstico era bem menor do que nos dias atuais, em que se dispõe de procedimentos terapêuticos específicos para a maioria das enfermidades. Tornou-se necessário, então, um diagnóstico exato ou **diagnóstico de certeza**.

O caminho a percorrer para chegar ao diagnóstico de certeza pode ser breve ou longo, na dependência da complexidade de cada caso. Quando se procede ao exame clínico de um paciente, levantam-se **hipóteses diagnósticas**, que devem ser confirmadas ou afastadas após a realização de exames complementares, os quais serão escolhidos considerando-se a sensibilidade e a especificidade. De posse de todos os elementos que podem auxiliar no raciocínio clínico, efetua-se o **diagnóstico diferencial**, que consiste na análise comparativa das várias enfermidades que podem apresentar quadro clínico semelhante, procurando-se eliminar sucessivamente as de menor probabilidade em face dos dados disponíveis.

Definido por Harvey e Borddley “como a arte de distinguir uma doença de outra, estabelecendo uma ou mais causas bem definidas para explicar as alterações apresentadas pelo paciente”, o diagnóstico diferencial deve levar em conta as enfermidades **prováveis** em cada caso e não todas as **possíveis** causas de um ou mais sintomas apresentados pelo paciente. Chega-se, assim, ao diagnóstico mais provável ou, mesmo, ao **diagnóstico de certeza**.

Quando o mesmo paciente apresenta mais de uma condição mórbida, considera-se como **diagnóstico principal** o referente à mais importante das afecções e como **diagnósticos secundários** os demais, podendo-se denominá-los **comorbidade**.

Check-up, rastreamento ou screening

Com as práticas de rastreamento e *screening* (mais conhecido como *check-up*) preconizadas pela medicina preventiva, levando-se em conta o potencial revelador dos métodos de imagens e exames laboratoriais, poderemos ter frequentemente um achado incidental, sem significância clínica (sobrediagnóstico). De modo geral, são representadas por nosologias indolentes ou latentes, por vezes, sequelas antigas, que se tornam iatropatogênicas, provocando insegurança, medo e ansiedade.

Em algumas situações perduram por anos seguidos, até que a situação se esclareça. Por exemplo, os achados de nódulos solitários no pulmão ou tireoide, que exigem acompanhamento clínico, radiológico e por vezes procedimentos invasivos (punções, biopsias, endoscopias, cateterismos e outros), doença de pequenos vasos cerebrais quando se realiza uma ressonância magnética cerebral, cistos benignos em rins e fígado, que exigem acompanhamento médico, sem desdobramentos ulteriores. Podem gerar procedimentos diagnósticos sobrepostos, sobretratamentos com custos e desgaste emocional desnecessários. Nestas situações, cabe ao médico assistente ter habilidade e capacidade de dar segurança ao seu paciente, de forma convincente e tranquilizadora e proceder o acompanhamento que se fizer necessário, até que a situação se esclareça.

Comprovação diagnóstica

Na prática médica atual, torna-se imperioso que exista comprovação diagnóstica na etapa final do processo de se identificar determinada doença. Isso é importante não apenas para o planejamento terapêutico, cada vez mais específico, mas também para fins periciais (perícia médica), perícia securitária (indenizações, seguro de vida), perícia judicial (danos e lesões corporais traumáticas, mortes violentas). Em todas estas condições, deve-se ter como base os recursos que comprovam o diagnóstico. No âmbito restrito das ações judiciais contra o médico, sua principal defesa é um prontuário bem-feito, detalhado, incluindo os elementos que comprovam o diagnóstico.

Na relação com o paciente e seus familiares, principalmente em situações com risco de vida ou de sequelas graves, nada melhor do que uma investigação clínica rigorosa que culmina com um diagnóstico comprovado por métodos modernos.

Exemplos de comprovação diagnóstica

Em boa parte das doenças infecciosas pode ser indispensável o diagnóstico etiológico.

Demonstração do BAAR (*Mycobacterium tuberculosis*) é praticamente obrigatória para se firmar o diagnóstico de tuberculose, mesmo quando há lesões radiológicas ou tomográficas altamente sugestivas.

Da mesma maneira, provas sorológicas são indispensáveis quando se levanta a possibilidade de síndrome da imunodeficiência adquirida.

Nas neoplasias benignas ou malignas, a demonstração em exames citológicos e/ou histopatológicos da presença de células neoplásicas é condição essencial para se comprovar o diagnóstico que será o ponto de partida no diálogo com o paciente e seus familiares, além de ser fundamental para que seja feita uma proposta terapêutica correta e podermos considerar o prognóstico.

Diagnóstico por computador

Desde os anos 1970, vêm sendo propostos sistemas de apoio diagnóstico a partir dos trabalhos de Shortliffe *et al.* que desenvolveram o programa MYCIN para diagnóstico e tratamento na área de infectologia. Estes sistemas são frutos da tecnologia da informação, um derivativo da inteligência artificial. Eles dependem mais da quantidade de conhecimentos neles depositados do que da capacidade de adquirir conhecimentos. Vários outros programas foram propostos e testados: Internist e sua variante QMR, que funcionam com reconhecimento de padrão e associam raciocínio probabilístico, o Consultor, o Iliad e o Dxplain tentam elaborar diagnóstico através de escores que são atribuídos à relação entre achados clínicos e doenças. Todos foram testados comparativamente com os recursos clássicos de elaboração diagnóstica, concluindo-se que só deveriam ser usados por médicos capazes de identificar e utilizar informações relevantes e ignorar as irrelevantes. Ficando reservados para ambientes de trabalho controlados.

É preciso entender que **computador ainda não pensa**, e que mesmo tendo um excelente banco de dados e programas que consigam associar dados, utilizando equações matemáticas e algoritmos, estamos longe de dispormos de diagnósticos elaborados por computadores. O melhor que ainda se consegue são hipóteses diagnósticas cada vez mais consistentes com a utilização da inteligência artificial.

A perícia diagnóstica a que nos referimos anteriormente exige raciocínio lógico (racional), raciocínio abstrato, intuição (raciocínio analógico), experiência, vivência e as emoções que permeiam o grande encontro entre o médico e seu paciente, situação ímpar que os computadores não podem simular.

Acertos e erros diagnósticos

Se a busca do diagnóstico é o alvo de toda a ação dos médicos, qual seria a margem de acerto nos processos diagnósticos?

Vários estudos revelam que a margem de acertos depende fundamentalmente da qualidade da anamnese, a qual responde por **80 a 85% dos acertos**. O exame físico contribui com **8 a 10%**; sendo que os exames complementares colaboram com uma pequena parcela de acertos (Hampton *et al.*, 1975; Fletcher e Fletcher, 1983; Sackett e Rennie, 1992).

Fatores que dificultam o diagnóstico

As dificuldades diagnósticas costumam ocorrer nas seguintes situações:

- Doença em estágio inicial, com sintomas inespecíficos
- Doença comum, mas com manifestações atípicas
- Doença psiquiátrica
- Doença mascarada
- Desconhecimento da doença
- Paciente portador de multimorbidades
- Vícios da semiótica ou do raciocínio clínico.

Pode-se classificar os erros diagnósticos não intencionais (diversos dos erros cometidos por imperícia, imprudência ou negligência), também chamados de fatalidades da profissão médica, da seguinte maneira:

- Por ignorância ou desconhecimento da enfermidade e de sua história natural
- Anamnese inadequada, inconsistente, superficial ou desconexa

- Semiotécnica defeituosa: incompleta, apressada ou incorreta
 - Más condições do exame: local inadequado, iluminação e conforto prejudicados
 - Condições clínicas especiais: paciente sequelado, obeso mórbido, por exemplo,
 - Pacientes não colaborativos, agressivos, agitados
 - Valorização exagerada de detalhes
- Má interpretação dos exames complementares ou valorização indevida
- Solicitação irracional de exames complementares – compulsiva, sem a devida correlação com os achados clínicos e com o que se pretende evidenciar ou documentar
- Manipulação do médico pelos pacientes, pelo medo, pela mídia e pelo bolso: pacientes incisivos, que ameaçam ou chantageiam o médico ou em alguns casos, profissionais que recebem “comissões” para solicitarem determinados exames (geralmente os da “moda”) sem necessidade ou validade científica
- Descompromisso com o seguimento clínico e a titularidade para com o paciente. Em que o “conluio do anonimato”, na expressão de Balint, diluirá a responsabilidade do diagnóstico e do tratamento, com múltiplos médicos, de variadas especialidades, múltiplas opiniões, sem a presença de um coordenador de equipe e gerenciador dos trabalhos oferecidos.

PROGNÓSTICO

O prognóstico (do grego *pro* – para diante + *gnosis* – conhecimento, ou seja, prever pelo conhecimento) enseja desafios ao médico.

Em que pese conhecer a história natural das enfermidades, para se prever a evolução e suas possíveis consequências, as comorbidades que gravitam em torno do diagnóstico principal e estimar probabilidades para as principais intercorrências às quais o paciente está sujeito, estes elementos por si sós não bastam para um prognóstico preciso.

O prognóstico pode ser construído quanto à vida, à validez (incapacidade temporária ou permanente e invalidez) e quanto ao restabelecimento (cura) do paciente.

O prognóstico é fruto de um exercício acurado de conhecimentos, vivências, experiências, além dos dados fisiopatológicos e probabilísticos, uma vez que cada indivíduo tem a sua singularidade, suas reservas, seus instrumentos de reação frente à adversidade, suas crenças e fantasias. Aliado ao acesso rápido à internet e à mídia, com a democratização dos conhecimentos alimentando no paciente e nos familiares falsas promessas, dúvidas e esperanças vãs, é necessário extrema cautela ao se fazer prognóstico.

Pode ser balizado através de algoritmos, como a escala de Framingham para avaliar fatores de risco cardiovasculares (idade, sexo, índice de massa corporal, antecedentes, dados laboratoriais, pressão arterial), inferindo a probabilidade de se predizer percentualmente o risco de ocorrência de um evento em um determinado período de tempo.

Além da comprovação diagnóstica, a avaliação prognóstica é indispensável em medicina do trabalho, em perícia médica administrativa (institutos de seguridade social como o INSS), pois é através do prognóstico que se quantifica o prêmio a ser pago em perícia securitária e em medicina legal no contexto da perícia judiciária.

Exemplo significativo do valor do prognóstico é quando estamos frente a um portador de doença terminal (neoplásica ou crônica degenerativa, por exemplo), em que os familiares e responsáveis pelo paciente solicitam informações quanto ao tempo de vida restante, para dar tratativas a diversos procedimentos (providências quanto aos desejos firmados em vida estipulados no testamento vital, também chamados de diretivas antecipadas de vontade e outras deliberações familiares e jurídicas). Nestes casos os médicos se valem do conhecimento da história natural da enfermidade, dos sinais premonitórios de morte (instabilidade hemodinâmica, arritmias respiratórias, falência progressiva de órgãos, deatexia, inquietação, diaforese, cianose intensa, oligoanúria, icterícia progressiva, torpor) para emitirem parecer.

A mesma importância se aplica ao processo de doação de órgãos, em que a definição prognóstica quanto à finitude da vida desencadeia vários processos relacionados à captação e à seleção de receptores.

Por fim, como se procurou demonstrar, a medicina moderna tem como base o diagnóstico, em seus vários aspectos, a partir do qual será possível definir proposta terapêutica e o estabelecimento do provável prognóstico.

BIBLIOGRAFIA
